

基于多学科合作延续性管理在人工流产高危患者中的应用

卢建娣 池苗 刘韦伟

广东省珠海市妇幼保健院南琴院区妇科门诊 广东珠海 519000

【摘要】目的：探讨基于多学科合作延续性管理在人工流产高危患者中的应用效果。**方法：**选取2024年1月1日—6月25日于本院就诊的519例人工流产高危患者作为研究对象，采用随机数字表法将其分为对照组($n=259$)和观察组($n=260$)。对照组患者采用常规院外延续性管理，观察组患者采用基于多学科合作的延续性管理。比较两组患者的避孕知识知晓率、避孕措施使用情况及对延续管理的满意度。**结果：**干预后，观察组患者避孕知识知晓率高于对照组，差异具有统计学意义($P<0.05$)；观察组患者COC使用率高于对照组，差异具有统计学意义($P<0.05$)；两组患者IUD及曼月乐环使用率比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；观察组患者安全套使用率低于对照组，差异具有统计学意义($P<0.05$)；观察组患者对延续管理的满意度高于对照组，差异具有统计学意义($P<0.05$)。**结论：**对人工流产高危因素人群应用基于多学科合作的延续性管理，可提升女性的避孕知识知晓率，改进避孕行为与措施，提升患者对延续管理的满意度，值得推广应用。

【关键词】人工流产；高危患者；多学科；延续性管理

【中图分类号】R473.71

【文献标识码】A

【文章编号】2097-1958(2025)01-0124-03

人工流产作为避孕失败后的补救措施，在全球范围内具有普遍性。然而，随着性观念的开放、医疗技术的进步，人工流产率逐年上升，但其中高危因素人群的比例亦不容忽视^[1]。这类人群包括多次流产、年龄偏小、剖宫产术后、合并基础疾病等患者，其在接受人工流产后更易出现并发症，如感染、出血、子宫穿孔等，不仅给女性患者身体健康带来严重威胁，还可能对其心理健康产生长期影响，甚至影响到其生活质量、社会功能^[2]。既往国内的研究多侧重于探讨流产高危因素的识别与评估，旨在通过精确诊断、评估，为高危人群提供更为精准的干预措施^[3]。而随着医疗技术的不断进步和医疗模式的转变，多学科延续性管理将成为未来医疗服务的重要发展方向。在人工流产领域，多学科延续性管理将更加注重患者的整体健康需求，通过个性化治疗方案、精准化医疗服务，为患者提供更加全面、高效的医疗服务^[4]。基于此，本研究旨在探讨基于多学科合作延续性管理在人工流产高危患者中的应用效果，以期为临床实践提供参考。现将方法与结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2024年1月1日—6月25日于本院就诊的519例人工流产高危患者作为研究对象，采用随机数字表法将其分为对照组($n=259$)和观察组($n=260$)。对照

组患者年龄17~46岁，平均年龄(33.96 ± 2.73)岁；人流高危因素：半年内重复人流者1例，哺乳期者3例，年龄 <20 岁者1例，稽留流产者89例，既往有不良孕产史者1例，累计人流次数 ≥ 3 次者29例，剖宫产1次者34例，剖宫产2次者24例，剖宫产3次者1例，剖宫产再孕史8例，剖宫产史3例，人工流产总数超过3次者3例，其他62例。观察组患者年龄16~46岁，平均年龄(34.06 ± 2.72)岁；人流高危因素：半年内重复人流者5例，剖宫产1次者8例，剖宫产2次者3例，剖宫产再孕史113例，哺乳期者1例，哺乳期或剖宫产术后半年内或足月分娩后3个月内者2例，带器妊娠（包括宫内节育器变形、嵌顿等）者1例，低龄 <20 岁者3例，稽留流产者11例，既往有不良孕产史者1例，累计人流次数 ≥ 3 次者6例，年龄 <19 岁或 ≤ 50 岁者5例，人工流产总数超过3次者49例，其他52例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义($P>0.05$)，具有可比性。

纳入标准：(1)属于人工流产高危因素人群；(2)年龄 ≥ 16 岁；(3)能配合完成研究；(4)神志清醒，无意识障碍；(5)自愿参与研究，且知情。

排除标准：(1)难以正常交流或存在听力障碍者；(2)伴有认知功能障碍；(3)合并其他严重脏器类功能不全；(4)临床基线资料不完整者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规院外延续性管理，内容如下：

1.2.1.1 建立健康档案 为每位高危因素患者建立详细的健康档案，记录其基本信息、病史、手术情况、用药记录等。档案实时更新，以便医务人员随时掌握最新情况。

作者简介：卢建娣(1977—)，女，汉族，广东珠海人，副主任护师，本科，研究方向为护理。

1.2.1.2 定期随访与评估 设立专门的随访团队,对高危因素患者进行定期随访,内容包括询问患者恢复情况、解答疑问、提供健康指导等。

1.2.1.3 针对性健康教育 针对患者具体病情、需要,提供个性化的健康教育,包括流产后饮食、休息、运动、卫生等方面,以及预防感染、促进恢复的方法。

1.2.1.4 心理支持与疏导 医务人员关注患者心理状态,通过倾听、安慰、鼓励等方式,帮助患者缓解心理压力,树立积极心态。持续管理1个月。

1.2.2 观察组 采用基于多学科合作的延续性管理,内容如下:

1.2.2.1 高危因素的识别与评估 医疗团队对本院登记的适龄妊娠或分娩女性进行全面、细致的评估,识别出存在高危因素的患者。高危因素包括但不限于:年龄、既往病史、多次人流史、自然分娩或剖宫产史、半年内是否人工流产、是否稽留流产、哺乳期、既往妊娠期是否合并并发症、合并慢性疾病、心理状态、子宫手术史等。对于识别出的高危因素患者,建立专门的档案,记录其详细信息、病情特点、治疗方案^[5]。

1.2.2.2 成立多学科管理团队 由2名妇科医生、1名心理咨询师、2名营养专科护士、2名妇女保健专科护士相关专业人员组成多学科管理团队,明确各自职责和协作机制,确保患者在院内外均能得到全面、系统的医疗服务。

1.2.2.3 制订个体化管理计划 根据患者具体病情、需要,团队共同制订个性化的管理计划,包括流产后恢复指导、心理支持、营养调整、康复训练等多个方面,给予全面、细致的照护。

1.2.2.4 强化院内外衔接 建立院内外衔接机制,确保患者在出院后能够得到及时的随访和指导。在院内通过微信平台构建微信公众号、微信群聊等,患者在出院后或门诊处加入微信群,通过群聊,院外随访人员详细了解患者的恢复情况,解答患者疑问,并根据具体情况调整管理计划。如为患者提供详细的复方口服避孕药(COC)等高效避孕措施咨询与指导,解释各种避孕措施的作用机制、使用方法、注意事项等。

1.2.2.5 提供心理支持与疏导 通过量表与问卷了解患者心理状态,心理咨询师及时关注患者心理状态,针对结果予以个体化心理疏导,帮助缓解心理压力,调整心态。

1.2.2.6 实施营养与康复训练 根据患者营养状况、身体状况,营养专科护士和妇女保健专科护士提供个性化的营养指导和康复训练,通过调整饮食结构、增加营养

摄入、进行适度的康复训练(腹式呼吸训练、凯格尔运动等)等方式,帮助患者恢复健康^[6]。

1.2.2.7 定期评估与调整 团队定期对患者进行评估,了解其恢复情况、管理效果。根据评估结果,及时调整管理计划,确保予以有效、精准的医疗服务。定期总结、反馈,发现问题及时整改,并鼓励患者提出宝贵意见、建议,为管理工作的持续改进提供参考。持续管理6个月。

1.3 观察指标

1.3.1 避孕知识知晓率 采用自制避孕知识调查问卷进行评价,满意百分制, ≥ 80 分为合格。

1.3.2 避孕措施使用情况 包含COC、宫内节育器(IUD)、曼月乐环等。

1.3.3 对延续管理的满意度 采用自制满意度调查问卷进行评价,满分为100分,非常满意 ≥ 85 分、75分 $<$ 满意 <85 分、65分 $\leq$ 基本满意 ≤ 75 分、不满意 <65 分。

1.4 统计学方法

应用SPSS 23.0统计学软件分析本研究数据,计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,采用 t 检验,计数资料以 $n(\%)$ 表示,采用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者避孕知识知晓率比较

干预后,观察组患者避孕知识知晓率高于对照组,差异具有统计学意义($P < 0.05$),详见表1。

表1 两组患者避孕知识知晓率比较 [$n(\%)$]

组别	例数	避孕知识知晓率
对照组	259	230(88.80)
观察组	260	249(95.77)
χ^2 值		8.852
P 值		0.003

2.2 两组患者避孕措施使用情况比较

观察组患者COC使用率高于对照组,差异具有统计学意义($P < 0.05$);而两组患者IUD及曼月乐环使用率比较,差异无统计学意义($P > 0.05$);观察组患者安全套使用率低于对照组,差异具有统计学意义($P < 0.05$),详见表2。

表2 两组患者避孕措施使用情况比较 [$n(\%)$]

组别	例数	高效避孕措施			安全套
		COC	IUD	曼月乐环	
对照组	259	144(55.60)	16(6.18)	40(15.44)	59(22.78)
观察组	260	167(64.23)	14(5.00)	51(19.62)	28(10.77)
χ^2 值		4.026	0.341	1.561	13.414
P 值		0.045	0.559	0.211	< 0.001

2.3 两组患者对延续管理的满意度比较

观察组患者对延续管理的满意度高于对照组,差异具有统计学意义($P < 0.05$),详见表3。

表 3 两组患者对延续管理的满意度比较 [n(%)]

组别	例数	非常满意	满意	基本满意	不满意	满意度
对照组	259	122	44	70	23	236(91.12)
观察组	260	185	40	29	6	254(97.69)
χ^2 值						10.625
P 值						0.001

3 讨论

随着医学技术的发展和观念的变化,人工流产已成为一种较为常见的终止妊娠方式。然而,对于存在高危因素的女性患者而言,人工流产后的恢复与护理尤为重要。近年来,随着医疗模式的不断发展和完善,多学科协作与延续性管理在患者医疗服务中占据越来越重要的地位^[7]。通过成立多学科管理团队、制订个性化管理计划、强化院内外衔接、提供心理支持与疏导、实施营养与康复训练等措施,可确保患者得到全面、系统的医疗服务。

本次研究重点探究基于多学科合作延续性管理在人工流产高危患者中的应用价值,结果显示,干预后,观察组患者避孕知识知晓率高于对照组,差异具有统计学意义($P<0.05$);观察组患者COC使用率高于对照组,差异具有统计学意义($P<0.05$);两组患者IUD及曼月乐环使用率比较,差异无统计学意义($P>0.05$);观察组患者安全套使用率低于对照组,差异具有统计学意义($P<0.05$);观察组患者对延续管理的满意度高于对照组,差异具有统计学意义($P<0.05$)。上述结果表明对人工流产高危因素人群应用基于多学科合作的延续性管理,可提升女性的避孕知识知晓率,改进避孕行为与措施,提升患者对延续管理的满意度。首先在人工流产前对患者进行高危因素识别与评估,利于及时识别高危因素,避免流产后出现不良反应与并发症^[8]。拟定多学科延续性管理方案时首先成立团队,邀请流产后延续管理相关医师共同参与患者的院外持续管理,根据患者的具体情况和需求,制订个性化的管理干预计划,如流产后恢复指导、心理支持、营养调整、康复训练等,促使患者能获得优质、高效的延续管理服务^[9]。在延续管理中详细介绍各种避孕措施,给予患者专业指导,帮助患者消除疑虑,能安全有效地采取避孕措施,并加强监管,提升患者自我保护能力;多学科团队始终将患者需求、感受放在首位,通过耐心解答问题、关心患者感受等方式,表达对患者的尊重与关怀,提高患者对延续管理的满意度,并积极收集患者的反馈、建议,提升其对延续管理的认可度^[10]。

综上所述,对人工流产高危因素人群应用基于多学科合作的延续性管理,可提升女性的避孕知识知晓率,改进避孕行为与措施,提升患者对延续管理的满意度,值得推广应用。

参考文献

[1] 杜学礼, 鲍勇, 徐婷. 上海市育龄妇女人工流产与生殖健康管理服务调查[J]. 中华全科医学, 2021, 19(7): 1167-1170.

[2] 包琳君, 叶丹, 陈玲玲. 流产后关爱用于人工流产后患者避孕管理的影响因素分析[J]. 中国妇幼保健, 2022, 37(9): 1652-1655.

[3] 王阿迪, 杨燕梅, 曾千红, 等. 延续性护理对门诊人工流产妇女避孕知识以及避孕措施应用的影响[J]. 当代护士(下旬刊), 2020, 27(4): 112-114.

[4] 田甜, 赵惊, 乔梦瑶. 延续性护理在人工流产患者中的应用[J]. 中国卫生标准管理, 2020, 11(4): 134-136.

[5] 中华医学会儿科学分会, 中国优生优育健康与出生缺陷防控专委会. 规范人工流产全程管理建议[J]. 中国计划生育和妇产科, 2021, 13(8): 6-9.

[6] 黄榕, 危秋平, 卓龙彩, 等. 柯氏评估模型在人工流产后患者延续护理效果评价中的应用[J]. 国际医药卫生导报, 2020, 26(10): 1464-1466.

[7] 黄美娟, 郁晓萍, 施丽青. 基于微信平台的延续性健康教育和人文关爱对接受人工流产术患者的康复效果[J]. 中西医结合护理(中英文), 2021, 7(7): 139-141.

[8] 刘松林. 探析延续性护理联合术后关爱护理在人工流产手术后患者中的应用效果[J]. 妇幼护理, 2024, 4(3): 523-525.

[9] 许友柳, 吴敏莉, 魏琼. 无痛人流流产术女性患者术后实施个性化心理护理结合延续性生活干预的分析[J]. 中外医疗, 2023, 42(19): 172-175, 180.

[10] 顾惠芳, 倪亚男, 虞晓蓝, 等. 延续性护理联合术后关爱护理对行人工流产手术后患者生育健康的影响[J]. 中西医结合护理(中英文), 2022, 8(8): 94-96.